

## KC桌面——外资精译

## 制药行业

## Ozempic悬崖：仿制药风险、机遇与瓶颈

Ozempic（司美格鲁肽）仿制药在加拿大、印度和巴西的出现，为糖尿病-肥胖市场的未来提供了洞察，这对原研药企（诺和诺德、礼来及其他品牌公司）以及仿制药公司、CDMO和原料药/器械供应商均有影响。



图表 1

## 社会变迁

## MS2026年关键主题

我们借助MS的全球布局，深入了解司美格鲁肽仿制药在各地方市场的影响。诺和诺德GLP-1药物Ozempic（司美格鲁肽）仿制药的到来，将推动糖尿病和肥胖市场的下一轮转变，首批国家将成为美国和欧洲的试验场。市场独占权到期后，Ozempic仿制药已在印度和加拿大上市，

首个仿制药应在未来几周内巴西上市。我们利用印度GLP-1药物的销售、销量和市场份额的细颗粒度数据，首次描绘出仿制药上市后的GLP-1市场图景。我们还绘制了巴西和加拿大的市场格局，预计将出现价格急剧下跌、销量扩张以及一个双层市场：低价司美格鲁肽与高价差异化GLP-1+药物（礼来的Mounjaro及未来创新药）并存。

我们认为，首批国家仿制药市场形成的洞察，将为投资者提供关于全球糖尿病-肥胖市场将如何持续演变的视角。跟踪这些国家的市场发展，将为投资者提供关于美国及欧洲糖尿病-肥胖市场在2030年代初/中期下一波专利到期时可能如何演变的洞察。这对于评估品牌肥胖/糖尿病药物的前景至关重要，首先是礼来和诺和诺德，但也包括其他原研药企（安进、罗氏、阿斯利康、辉瑞、Structure Therapeutics等）在该类别中的未来创新产品上市。我们预计仿制药行业中将出现品类赢家，拥有全球布局和整合供应链的仿制药公司更有可能捕捉到品类销量扩张带来的收益。

## 我们深入研究了新兴的全球司美格鲁肽仿制药供应链。

本报告还深入探讨了仿制药全球供应链的形成，以解决一个关键的投资者争论：随着仿制药加速GLP-1药物的可负担性并推动其在糖尿病和肥胖领域的更高渗透率，仿制药行业能否实际供应这一更大的需求？我们认为，中国供应商正在扩大足够产能，为仿制药生产商提供所需的司美格鲁肽原料药（API），以生产注射用仿制药（尽管我们认为，扩大司美格鲁肽口服制剂的产能将



图表 2

## 肥胖——一个庞大且不断扩大的机遇

### 2025年肥胖人口



图表 3

全球10亿人



图表 4

美国1.1亿人

在1.1亿美国患者中，雇主选择加入率约50%



图表 5

Medicare开放约2000-2200万患者准入



图表 6



图表 7

## 司美格鲁肽仿制药全球市场形成：逐国分析

### 加拿大

（美国/欧盟的蓝图）



图表 8

- 约20-25亿美元GLP-1市场（2025年）；约15-20亿美元司美格鲁肽
- 2款仿制药已上市（Dr Reddy's, Apotex）；4款以上正在审评中
- 第三款仿制药触发强制降价65% → 价格从约150美元/月降至2027年约50美元/月

### 印度

（大众市场扩张）



图表 9

- 自2026年3月以来，13家公司，26款仿制药上市
- 价格低至约15美元/月（西林瓶）至60-70美元/月（高端注射剂）
- 司美格鲁肽销量增长超6倍（2026年2月至4月）；仿制药销量占比超80%
- 市场从1.23亿美元（2025年）增长至约10亿美元（2030年）
- 礼来Mounjaro增长约10%，尽管有仿制药（光环效应）

### 巴西

（可负担性解锁）



图表 10

- 首款仿制药（EMS/Ozivy）于2026年5月获批；17份申请正在处理中
- 当前价格160-320美元/月 → 预计2027年约60美元/月
- GLP-1市场：约50亿美元（2028年）
- 礼来预计将以Mounjaro主导品牌药板块

## 中国

（延迟但巨大的销量潜力）



图表 11

- 司美格鲁肽专利于2026年3月到期；CSFTA将独占期延长至2027年4月
- 1.48亿成年糖尿病患者；GLP-1在糖尿病中的渗透率低于10%
- 截至2024年8月，226家中国API供应商；90份FDA DMF中74份来自中国
- 礼来投资30亿美元，为期10年，在中国建设Foundayo口服制剂生产设施
- 大型API制造商正在扩大产能至多吨级



图表 12

## 司美格鲁肽仿制药机遇



图表 13

>全球1亿患者仅需10-15吨注射用司美格鲁肽API即可供应

但口服制剂在等效剂量下需要63-73倍的API：Wegovy口服片剂维持剂量下每100万患者需要约9.1吨API，而Wegovy注射剂仅需125公斤



图表 14

注射用API供应可控——大规模口服司美格鲁肽对仿制药而言仍是结构性挑战



图表 15

## 灌装-封装可能成为瓶颈

### 注射用司美格鲁肽

- 52-374毫克/患者/年（取决于剂量）
- 10-15吨API足以供应全球>1亿患者
- 中国API行业已具备多吨级产能



图表 16

### 口服司美格鲁肽

- 高达9,125毫克/患者/年（维持剂量）
- 仅100万维持剂量患者就需要9.1吨API
- 短期内大规模仿制口服制剂生产不太可能



图表 17

## 灌装-封装可能成为瓶颈

- API生产：注射剂可控
- 笔式/器械：多家供应商正在增加产能
- 灌装/封装潜在瓶颈：初始F&F供应商（OneSource, Gland Pharma）正在扩大产能；西林瓶作为变通方案（印度仿制药，美国和巴西的复方药房）



图表 18



图表 19

## 礼来 vs 诺和诺德：竞争定位

### 礼来（超配）

- Mounjaro（GLP-GIP）在III期头对头数据上具有差异化
- Foundayo：真正的小分子 → 全球可规模化口服制剂
- 管线：Retatrutide（GLP-GIP-胰高血糖素），Eloralintide（胰淀素）
- 肠促胰岛素业务：600亿美元（2026年）→ 1010亿美元（2035年）
- 约53%国际份额，约60%美国份额——全球肠促胰岛素领导者



图表 20



图表 21



图表 22

## 诺和诺德 (EW)

- 司美格鲁肽（仅GLP-1）面临仿制药侵蚀
- 口服Wegovy：肽类 → API规模化限制阻碍美国以外地区上市
- 市场共识预测2033年司美格鲁肽销售额230亿美元，该预期可能面临风险
- CagriSema（2027年）、zenagamtide口服制剂（2030年）——依赖执行情况



图表 23

## 口服GLP-1的转折点

### 肽类口服GLP-1（例如口服司美格鲁肽）

- 所需API量约为等效注射剂型的63 – 73倍
- 疗效优于Foundayo
- 制剂相关的饮食限制

■ 随着全球需求扩大，可能面临供应约束



图表 24

## 为何重要

- 口服疗法可能推动GLP-1下一阶段的大规模应用
- 制造可扩展性可能成为关键竞争差异化因素
- 供应链设计可能影响长期市场份额与地域扩张



图表 25

## 小分子口服GLP-1（例如礼来Foundayo、诚益生物Aleniglipron）

- 真正的小分子疗法，而非肽类
- 传统口服固体制剂制造工艺
- 制造复杂性较低
- 全球规模化潜力更大
- 更有利于广泛的国际推广



图表 26

## 关键争议总结

为何仿制药首次进入市场构成GLP-1/糖尿病肥胖市场的关键事件？专利保护期结束后市场独占权到期，司美格鲁肽/Ozempic（诺和诺德用于糖尿病的GLP-1药物）的仿制药已在印度和加拿大上市，未来几周将在巴西上市；其他国家和地区将在未来几年跟进，最大市场（美国和欧洲）将在2030年代初期至中期迎来仿制药。由于Ozempic和Wegovy等注射用GLP-1的制造成本相对较低，仿制药竞争将导致显著的价格侵蚀（例如加拿大第一年内价格降幅超过65%）。这将直接影响诺和诺德现有的GLP-1业务（约占销售额的75%），该公司承诺利用其制造成本优势，在市场独占权已失效的国家与仿制药厂商进行价格竞争。司美格鲁肽可负担性提升应能推动GLP-1在各国的更广泛应用，尤其是在这些药物主要由患者自费的中低收入国家，这将推动GLP-1品类销量扩张。我们预计司美格鲁肽专利到期后的国家将出现两级市场：司美格鲁肽成为可负担的大众市场基础分子，而礼来、诺和诺德及新进入者（安进、罗氏、阿斯利康、辉瑞、结构治疗等）的口服GLP-1和下一代产品（GLP-1+）将在更高价值的品牌领域竞争。

为何存在关于司美格鲁肽仿制药供应链的争议？司美格鲁肽是一种肽类药物，因此不像他汀类等传统小分子药物那样易于仿制和大规模生产。诺和诺德与礼来的注射用GLP-1产品Ozempic/Wegovy（司美格鲁肽）和Mounjaro/Zepbound（替尔泊肽）的成功导致2021至2024年间美国市场短缺，全球供应也受限。这些药物制造过程中的关键瓶颈在于灌装与封装（F&F）环节，即将活性成分转化为无菌液体并包装成即用型注射笔或装置。灌装与封装需要高度受控的洁净室空间以最大限度降低污染风险，需经FDA检查/批准，且新建F&F产能需要3年以上时间。诺和诺德与礼来投资数百亿美元建设更多F&F产能，包括诺和诺德2024年从Catalent收购三个F&F生产基地。

此后，制造工艺优化与新F&F基地投产相结合，解除了注射剂的制造瓶颈，诺和诺德与礼来已能够供应美国市场并扩大其注射剂业务的地域覆盖。然而，投资者存在争议：仿制药厂商能否复制诺和诺德与礼来的供应链，生产足够多的注射用仿制药以满足可负担性提升所激发的增长需求？我们的分析表明，虽然中国在原料药（API）方面有大量产能扩张，但F&F产能情况尚不明朗，仿制药厂商可能需要在未来几年投资建设产能以覆盖最大市场（美国和欧洲），或引入F&F瓶颈较小的剂型（例如多剂量西林瓶而非注射笔/自动注射器）。

肽类与小分子，为何在GLP-1口服药竞争以及仿制药影响争议中如此重要？答案在于便利性和可扩展性。诺和诺德的口服GLP-1是将司美格鲁肽（一种肽类）重新制剂为药片形式。

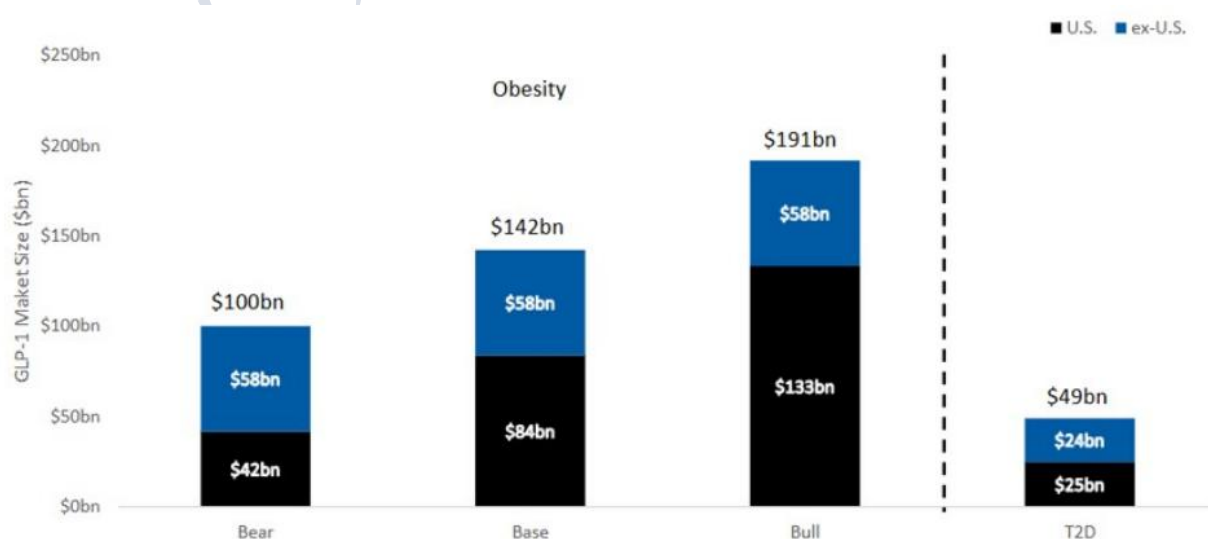
肽类是一种通常无法口服的分子类型，因为它们在到达体内靶点前大多会被胃酶分解。为克服这一限制，诺和诺德利用了一种制剂技术（SNAC）来改善肽类吸收，但存在两个缺点：1）需在早晨空腹服用，且服药后30分钟内不得进食、饮水或服用其他药物；2）需要大量API（活性药物成分）以弥补口服途径吸收率低的问题。事实上，司美格鲁肽口服制剂维持剂量所需的API量是等效注射剂型的63-73倍。这增加了制造成本，也限制了该药片的可扩展性，使诺和诺德仅能覆盖美国及部分美国以外市场。这也限制了仿制药厂商规模化生产诺和诺德口服药仿制药的能力。相比之下，礼来的口服药Foundayo（orforglipron）是真正的小分子GLP-1受体激动剂，更易于大规模制造，且没有司美格鲁肽口服药的禁食/饮食限制。但我们注意到，跨试验比较显示司美格鲁肽在疗效方面更优（Foundayo第72周体重减轻约12%，而Wegovy口服药第64周为16-17%）。

## 仿制药争议如何影响MS全球肥胖模型

3/15

预测？在我们最新发布的关于GLP-1市场扩张的全球报告中（参见《生物制药：减肥药物：追踪GLP-1的“解锁”》（2026年4月7日）），我们阐述了对全球GLP-1市场（包括品牌药和仿制药）的预期，并在基准情景下预测减肥药市场规模为1420亿美元（假设品牌药市场通过差异化和市场细分保持更高价值），在悲观情景下为1000亿美元（包括定价压力和仿制药竞争）。我们分别预测2035年GLP-1糖尿病市场规模为490亿美元，从而使我们的基准情景下全球GLP-1市场规模达到1900亿美元（2026年市场规模约为900亿美元）。特别是来自加拿大市场动态的洞察，将为我们判断其他发达市场在价格、渗透率/销量以及口服和创新品牌药细分市场增长方面将如何演变提供依据。

图表2：2035年GLP-1减肥药市场：乐观、基准和悲观情景



图表 27

资料来源：MS 估计

## 关键结论

## 1) 我们认为仿制药生产商获取原料药将不成问题，但灌装与封装（F&F）可能成为瓶颈

## 2) 加拿大、印度和巴西的仿制药市场形成表明价格急剧下降、销量扩张以及两级市场的出现

市场形成已在加拿大（第二大 GLP-1 市场）开始；我们预计价格将急剧下降。加拿大将成为诺和诺德与仿制药生产商的关键战场，因为它为美国及欧洲在 2030 年代早期/中期可能发生的情况提供了最佳蓝图。我们估计 2025 年加拿大 GLP-1 市场规模为 20-25 亿美元，其中包括 15-20 亿美元的司美格鲁肽销售额。Dr Reddy's 和 Apotex 已推出市场上首批两款仿制药；未来几个月内第三款仿制药（可能来自山德士、梯瓦、Taro 或 Aspen）的上市，将触发品牌药价格强制下调 65%，导致价格从仿制药上市前的约 150 美元/月降至 2026 年底前的约 50 美元/月。我们预计 2027 年定价压力将持续，因为仿制药生产商将争夺市场份额，我们预测加拿大司美格鲁肽市场将通过销量增长和价格下跌稳定在 8-9 亿美元，其中诺和诺德将保留约 2.5 亿美元的尾部收入。

随着仿制药的进入，印度 GLP-1 市场可能从 2025 年的 1.23 亿美元扩大到 2030 年的约 10 亿美元。自 2026 年 3 月以来，已有 13 家公司推出了 26

款司美格鲁肽仿制药，涵盖多种剂型（单剂量、多剂量、西林瓶和药片），价格从西林瓶的约 15 美元/月到更高端注射剂的 60-70 美元/月不等。两家公司已推出口服片剂（仿制瑞倍适），规格为 3 毫克、7 毫克和 14 毫克，每片定价约 1-2.4 美元。我们预计未来几个月将有更多产品进入市场。司美格鲁肽的销量在 2 月至 4 月间增长了 6 倍以上，仿制药已占据超过 80%

的司美格鲁肽销量，主要参与者开始涌现（Torrent、Lupin、DRL、Zydus 和太阳制药）。仿制药上市后，礼来公司凭借其穆峰达（替尔泊肽，GLP-GIP）的溢价定价，继续在价值上占据最大份额。礼来在 2026

年第一季度财报中指出，近期司美格鲁肽仿制药的上市对整个 GLP-1

市场产生了光环效应，穆峰达在面临仿制药竞争时实际上增长了 10%（参见此处）。诺和诺德的价值和销量绝对值保持在低位水平，市场扩张由仿制药驱动。我们预测市场将继续从 2025 年的约 1.23 亿美元增长到 2030 年的约 10 亿美元，市场将分化为大众市场的司美格鲁肽销量增长（可能由少数拥有供应链整合、器械能力和分销优势的规模化仿制药企业主导）和可能由礼来穆峰达主导的高端市场。

巴西首个司美格鲁肽仿制药已获批；我们预计价格将下降，随后市场将扩张，仿制药和礼来（在品牌药领域）将受益。来自本地制造商 EMS 的首款仿制药于 5 月 26 日在巴西获批，预计将于 6 月/7

月上市，可能还会有更多仿制药制造商跟进（17 项仿制药申请正在进行中）。巴西的品牌 GLP-1

市场目前渗透率较低，当前价格（160-320 美元/月）限制了品牌 GLP-1 在主要自费市场中对高收入患者的可及性；高昂的价格也导致形成了一个庞大的复方/非法进口市场，其规模可能达到正规市场的 3-4

倍。我们预测司美格鲁肽仿制药的引入将降低成本（到 2027 年降至约 60 美元/月）并提高渗透率，使巴西 GLP-1 市场从 2026 年的约 20 亿美元增长到 2028 年的约 80 亿美元。我们预计仿制药生产商（EMS、Hyperia 和全球竞争者）将成为主要受益者，而诺和诺德的业务将受损，礼来则应继续凭借穆峰达主导品牌药市场。我们巴西市场预测的风险可能来自复方/黑市的进一步扩张。

## 3) 股票结论：偏好礼来胜过诺和诺德，偏好具有全球影响力和整合供应链的仿制药公司，偏好规模化的原料药供应商

我们预计礼来（评级为超配）的业务更能抵御仿制药压力，原因在于：（1）穆峰达（替尔泊肽；GLP-GIP）与司美格鲁肽（GLP）相比，在肥胖症和 2 型糖尿病方面拥有头对头 3

期临床数据优势；（2）拥有作用机制新颖的管线药物组合，如 Retatrutide（GLP-GIP-胰高血糖素）和 Eloralintide（选择性胰淀素）；（3）拥有 Founday 小分子口服 GLP-1

药片（值得注意的是，这不是像诺和诺德口服 Wegovy

那样的肽类药物，后者限制了可扩展性，我们将在文中讨论）。礼来首席科学官最近指出，Retatrutide

也可能成为低体重指数肥胖症患者的“主力药物”，因为低剂量3期临床数据在减重、耐受性和剂量递增时间方面优于替尔泊肽（参见此处）。我们预测礼来肠促胰岛素业务销售额将从2026年的约600亿美元增长到2035年的约1000亿美元。参见我们今年早些时候的报告《追踪GLP-1的“解锁”》。

## 我们强调仿制药生产商/CDMO/供应商中的潜在受益者。

### 仿制药

- Dr. Reddy's（评级为等权重）：司美格鲁肽仿制药的早期进入者，拥有整合的原料药、合作的笔式注射器/灌装封装产能以及激进的扩张计划，使其成为加拿大、印度和其他市场的规模化低成本供应商。
- 山德士（评级为低配）：GLP-1仿制药是一个适度的近期机会，通过2026年下半年在加拿大/巴西的上市实现，上行空间仅取决于定价能否稳定在具有吸引力的水平，以及山德士能否成功成为市场份额领导者。长期上行空间将取决于对灌装封装的投资，以抓住美国和欧洲的机会。
- Hypera（评级为超配）：如果巴西司美格鲁肽仿制药能及时获批并成功上市，可能意义重大，尽管EMS具有先发优势/本地制造优势，但Hypera仍可通过医生渠道、零售覆盖和品牌建设获得潜在的市场份额。
- 联合实验室（3933.HK，评级为等权重）：中国司美格鲁肽仿制药的早期申报者，拥有糖尿病销售基础设施和更广泛的糖尿病肥胖症管线选择权，包括诺和诺德在中国以外的UBT251许可。

### APIs/CDMOs/其他

- 麦迪科技（3880.HK, EW）：具备可信的司美格鲁肽原料药产能及FDA进口资格，但更偏向多肽/寡核苷酸CDMO；不过我们注意到FDA进口数据显示麦迪科技已开始向美国出口司美格鲁肽原料药。
- Raia Drogasil（OW）：司美格鲁肽降价应能扩大巴西正规GLP-1药房市场，RADL有望受益于更高的销量、重复处方以及从进口/复方药向正规渠道的迁移。

### 药品包装

- 西氏医药服务（EW）：我们预计品牌GLP-1向仿制GLP-1的产品降级现象有限，这将使WST能够以其高价值产品组合服务仿制GLP-1市场，从而推动强劲营收增长传导至每股收益。此外，我们认为由于仿制药企无法获得与两大品牌GLP-1厂商同等的批量折扣，平均售价存在上行潜力。
- Stevanato集团（EW）：我们认为STVN将因与WST相同的上述原因受益于仿制GLP-1，但由于公司对GLP-1的敞口更高，受益程度将更大。

## 仿制司美格鲁肽的供应链构建

全球司美格鲁肽市场的形成将取决于仿制药企建立并扩大与诺和诺德、礼来相媲美的供应链能力。

## 原料药考量：注射剂可控，口服剂挑战大

司美格鲁肽原料药需求因剂型而异，从Ozempic

1mg所需的相对较低原料药量到Ozempic/Wegovy口服剂型所需的大剂量不等。

- Ozempic注射剂（52mg/患者/年至104mg/患者/年）：起始剂量为0.25mg/周（4周，1mg多剂量笔）；随后0.5mg/周（4周，2mg多剂量笔）；维持剂量为1mg/周（4mg多剂量笔）或2mg/周（8mg多剂量笔）。对患者而言，这意味着原料药需求为52mg/患者/年或104mg/患者/年，具体取决于维持剂量。

- Wegovy注射剂（125mg/患者/年至374mg/患者/年，高剂量）：Wegovy维持剂量为2.4mg/周（标准）至7.2mg/周（Wegovy高剂量）。这意味着原料药需求为125mg/患者/年（Wegovy标准）或374mg/患者/年（Wegovy高剂量）。
- Wegovy口服片（维持期患者最高9.125g/患者/年）：Wegovy口服片每日剂量为起始剂量1.5mg（一个月）/4mg（一个月），9mg（一个月）/25mg（维持）。在25mg维持剂量下，Wegovy口服片需要9.125g原料药/患者/年，是Wegovy注射剂2.4mg的73倍，是Wegovy高剂量的24倍。我们注意到，考虑到口服片近期上市，目前关于患者升级至高剂量的比例仍存在争议。
- Rybelsus/Ozempic口服片（维持期患者最高9.125g/患者/年）：用于糖尿病适应症的司美格鲁肽口服片，此前剂型（Rybelsus）为3mg/7mg/14mg每日；新品牌和新剂型Ozempic口服片对应为1.5mg/4mg/9mg，诺和诺德正计划推出25mg更高剂量。这将简化供应链，因为Ozempic口服片和Wegovy口服片实际上是同一种药物，具有相同的剂型和剂量（仅品牌和适应症不同）。

图表3：一名患者使用注射剂一年（最大/维持剂量）所需的原料药量

来源：MS

图表4：Wegovy口服片和Ozempic口服片所需的原料药量远大于注射剂

来源：MS

## 原料药生产：诺和诺德的杂交重组/合成路线 vs. 仿制药企的全化学合成路线

司美格鲁肽可通过半重组/半合成方法（诺和诺德）或化学合成（大多数仿制药企）生产。诺和诺德的生产路线可描述为半重组/半合成，肽骨架通过酵母基RNA重组方法生产，并通过化学方法引入额外修饰。相比之下，许多仿制药开发商通过化学肽合成生产原料药，通常采用固相肽合成（SPPS）或SPPS与液相肽合成（LPPS）混合方法，随后进行侧链修饰和广泛纯化。在审评仿制药企申请时，监管机构关注最终原料药是否相同以及路线特异性杂质是否得到控制。

半重组生产建立成本更高（初始资本支出要求高），但在规模化时效率更高；而化学合成路线进入门槛较低，但大规模生产时产率也较低。诺和诺德方法（酵母基肽骨架）的关键优势在于大规模生产时的效率和更好的产率优化机会，但建设产能资本密集且耗时更长。这对仿制药企而言并非易事，因为需要生物制品/发酵基础设施、技术和专有知识。相比之下，化学合成路线开发更快，生产链更灵活/可模块化，但与半重组路线相比不具备相同的产率优化机会。

我们预计原料药供应商和仿制药企能够以全球规模供应注射剂型所需的原料药，但为口服片生产足够的原料药将是一个挑战。

供应注射用司美格鲁肽所需的原料药量适中；粗略估计，仿制药行业仅需10-15吨原料药即可在全球供应超过1亿患者。以全球规模大规模供应Ozempic 1mg/周（对应Dr Reddy's和Apotex已在加拿大上市的4mg笔）市场所需的原料药似乎可控；52公斤司美格鲁肽原料药足以在维持剂量下供应100万患者。随着司美格鲁肽剂量升高，原料药需求也随之增加，供应100万使用Wegovy高剂量笔维持剂量的患者需要374公斤原料药。假设仿制药行业将仿制机会集中在Ozempic和Wegovy上，整个行业可用10至15吨原料药供应超过1亿患者。我们认为中国仿制药企、原料药供应商和CDMO公司已具备显著的原料药产能，并能在未来几年内提升至供应全球市场所需的水平。

5/15

我们认为，原料药和制剂技术方面的考量可能会阻止仿制药企大规模生产司美格鲁肽片剂仿制药，尽管我们注意到已有一些公司在印度推出了口服片剂（Rybelsus仿制药）。Ozempic片剂和Wegovy片剂所需的原料药量远大于注射剂型。例如，假设一年内100%依从，为100万维持剂量患者供药，Wegovy片剂需要9.125吨原料药，是Wegovy 2.4mg（100万维持剂量患者需125kg）的73倍，是Wegovy高剂量（100万维持剂量患者需374kg）的24倍。此外，除了纯粹的原料药产能，仿制药企还需要在通过口服途径吸收原料药方面，匹配诺和诺德更新的SNAC技术。然而，我们注意到仿制药企Torrent Pharmaceuticals已推出Rybelsus仿制药（Semalix），Dr Reddy's也已推出口

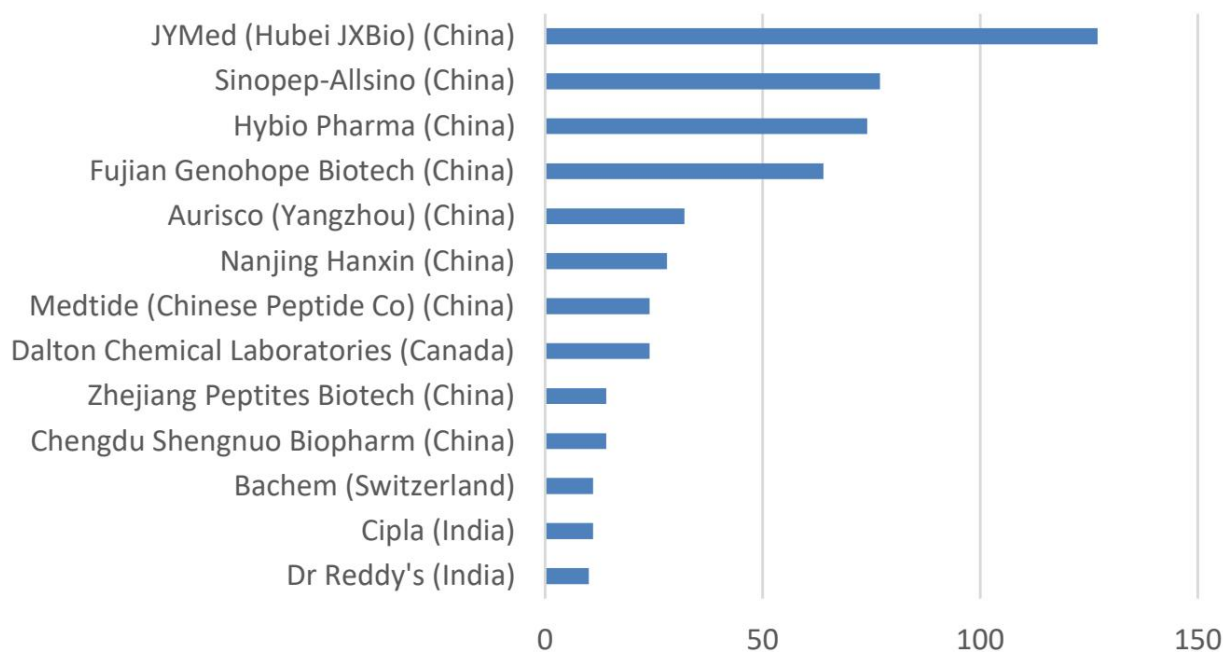
服版本（Obeda），但供应能力未知。其他几个口服片剂仿制药项目正在美国以外国家开发中。

图表5：原料药数量

来源：MS

## 中国正成为司美格鲁肽原料药的关键制造中心

图表6：向美国进口司美格鲁肽的公司，按出货量排名（不含诺和诺德）



图表 28

多年来，中国积累了大量的司美格鲁肽原料药产能，并且是全球最大的原料药供应国。中国的CDMO（专注于创新药）和原料药生产商（专注于仿制药原料药和制剂）已储备了大量产能，以应对中国和海外的仿制药上市，尽管并非所有生产商都选择分配产能，且上市公司的评论表明司美格鲁肽原料药质量参差不齐。

- 在美国，《哈奇-韦克斯曼法案》下的专利期限调整和专利期限延长提供了补偿监管审查过程中损失时间的延期。这些措施将化合物专利（US8129343）和长效GLP-1肽用于糖尿病/肥胖症的专利（US10335462）的到期日分别推迟至2031年12月和2033年6月。
- 在欧洲，补充保护证书起到相同作用，将专利到期日延长最多5年。这将司美格鲁肽的专利保护期延长至2031年3月。
- 然而，在中国，在2021年6月之前不存在此类机制，当时政府引入了类似美/欧模式的延期机制。司美格鲁肽（Ozempic）于2021年4月在中国首次获批用于糖尿病适应症，因此勉强错过了延期路径的颁布。该法律的适用也不具有追溯力。

为什么中国在规模化生产肽方面具有独特优势？基于以上背景，我们总结出中国积累如此多司美格鲁肽产能（或就此而言的肽产能）的以下原因。

- 作为世界原料药工厂的既有地位：全球约30%的原料药产能位于中国。自加入WTO以来的20多年里，中国的成本优势、庞大的化学人才库以及从制药价值链低端起步的意愿，使中国跃升为原料药领域的领导者，拥有40多家出口导向型上市原料药公司（见我们的入门指南）。作为合成化学专家，许多公司已开发出固相肽合成能力。
- 以更低成本运营：这一优势源于较低的劳动力成本和原材料价格（注）。这使得中国成为对成本更敏感的客户有吸引力的服务提供商。

- 司美格鲁肽专利到期较早：专利期限延长机制的延迟颁布导致到期日（2027年4月）比美/欧早4-5年。加上庞大的中国糖尿病人口（约占总成年人口的12%，来源），这为中国生产商投资司美格鲁肽原料药产能创造了强大动力。一些公司也在瞄准加拿大、巴西和印度的出口市场。截至2026年第一季度，已有74家中国公司获得FDA DMF注册，用于供应司美格鲁肽原料药，而在中国，已有13家提交了原料药供应申请，但尚无一家获批。如图表33所示，已有10多家公司提交了生物类似药申请，但领先者因中国-瑞士自由贸易协定（CSFTA）而受阻（新闻）。
- 庞大且渗透率低的国内市场：截至2024年，中国有1.48亿成年糖尿病患者。当前处方渠道的用药障碍包括报销水平低、针头恐惧症（见我们的调查）以及受到监管打击力度加大的灰色市场。换句话说，中国的原料药生产商可以转向两个方向：中国或海外。
- 掌握SPPS（固相肽合成）：SPPS是一种广泛使用的实验室化学合成肽技术。它在一个不溶性树脂珠上逐个连接氨基酸。司美格鲁肽是一种复杂的31氨基酸肽，带有脂肪酸侧链，使得大规模、高纯度生产在技术上具有挑战性。中国制造商已成功掌握大规模、高纯度生产司美格鲁肽等长链肽的核心技术，包括技术掌握度和工艺成熟度，这构成了显著的技术进入壁垒。多家领先制造商已实现司美格鲁肽的吨级量产，部分生产线设计规模达10吨级。
- 在肽基础设施上的重大资本支出：中国在TIDES（肽+寡核苷酸）领域的领先CDMO已投入大量资金进行产能建设。药明康德是领导者，其SPPS产能到2025年第三季度达到100,000升，并预计在2026年内增长30%至130,000升。仅2023年，其TIDES业务就生产了超过15吨的肽原料药和中间体（涉及50个从临床前到商业化的项目）。凯莱英到2025年底拥有45,000升SPPS产能，并预计在2026年内将其扩大至69,000升（+53%）。专注于TIDES的纯CDMO公司Medtide年产能超过一吨。其他供应商包括康龙化成、九源基因和四环医药。截至2024年底，四环医药拥有两套12,000升发酵系统，专门用于司美格鲁肽生产。
- 政府支持：根据Caplin Point Labs的评论（链接），中国政府的支持性政策在生物类似药/仿制药领域创造了一个高度竞争且分散的供应商基础，有500-600家公司，而印度只有7-10家大公司。
- 可观的出口市场：最初激励国内供应商基础的是中国自身的仿制药市场（现已推迟至2027年4月）和美国的配药市场。在美国对后者实施限制后，中国供应商已转向除中国外的其他仿制药市场，例如加拿大、巴西和印度。

6/15

量化司美格鲁肽原料药国内产能基础：CDMO与原料药厂商均大幅提升其多肽产能。截至2026年第一季度，美国FDA已向供应商授予90份司美格鲁肽原料药的DMF（药物主文件）。其中，74家为中国公司（占比82%），其次为8家印度公司（占比9%）。尽管司美格鲁肽的中国供应商数量众多，但仅有少数在FDA的绿名单上。麦科田（3880-HK）已披露其是合格供应商之一——“本集团的司美格鲁肽原料药已被列入美国FDA进口警示66-80的绿名单，表明其有资格进入美国市场而无需扣留。这一认可基于FDA对本集团生产设施及质量体系的评估，反映了本集团符合美国cGMP要求。”绿名单包含经FDA评估其设施和产品符合现行药品生产质量管理规范（cGMP）要求的外国制造商。在多肽产能方面，中国最大的供应商是CDMO药明康德和凯莱英，尽管这些公司主要服务于创新药合同。多家供应商拥有吨级年产能的多肽原料药，但并非所有公司都有司美格鲁肽的重大计划。我们列出以下潜在的司美格鲁肽供应商。健元医药、翰宇药业和江苏诺泰澳赛诺公开承诺供应司美格鲁肽原料药。麦科田拥有吨级多肽产能，但未就进军司美格鲁肽市场的意图发表评论（尽管FDA的发货数据显示，该公司正通过其子公司中国多肽公司向美国出口批次）。目前，其专注于创新药开发。

图表7：多肽及已知司美格鲁肽供应商（高亮行）

注：橙色表示公开意图进军司美格鲁肽原料药市场。来源：公司数据；MS

## 灌装与封装可能成为仿制药行业的初始瓶颈

基于多剂量注射笔的设备需求为每年每名患者13支注射笔。对于Ozempic，诺和诺德在全球范围内使用fletouch注射笔（每支笔含4周剂量）。对于Wegovy，诺和诺德在美国以外地区使用fletouch注射笔，在美国则使用一次

性每周注射笔（每年每名患者52支注射笔），不过该公司正等待Wegovy多剂量注射笔于2026年第二季度在美国获批。因此，仿制药生产商对注射笔的需求量在全球范围内（使用多剂量注射笔）可能仍为每年每名患者13支。

西林瓶剂型可提供更低的成本和更高的灵活性，并有助于缓解供应链瓶颈。Ozempic和Wegovy目前仅以预填充注射笔剂型提供；然而，诺和诺德正致力于在2026年推出Wegovy的西林瓶剂型。西林瓶剂型（西林瓶+单独的针头和注射器）是一个重要的考量因素，因为它可以降低制造成本，更重要的是，可以克服注射笔/设备及相关灌装与封装产能方面的潜在供应链瓶颈。我们注意到，已有三家仿制药生产商在印度推出了西林瓶剂型，另有其他公司表达了对剂型的兴趣。在加拿大，至少有一家公司（Vimy Pharma）也计划销售西林瓶剂型。我们注意到，美国和巴西的灰色市场/复方GLP-1药物大多也通过西林瓶剂型销售。

诺和诺德的总灌装与封装/设备产能尚不清楚，但我们估计，2025年Ozempic和Wegovy的全球销售额相当于每年约1.28亿支多剂量注射笔；我们预测需要约1.38亿支等效多剂量注射笔来支撑2026年的销售额。对于Ozempic，我们估计诺和诺德在2025年销售了约1亿支注射笔；我们使用了国际销售额（2025年为58亿美元），并假设平均每支注射笔价格为85美元，得出国际业务为6900万支注射笔。对于美国，我们使用了TRx数据（2025年为3000万支）。我们注意到，2025年3月，诺和诺德表示全球有700万患者正在接受Ozempic治疗，这相当于2025年3月年化注射笔销量为9100万支，与我们估计的2025年约1亿支一致。对于Wegovy，我们进行类似计算，假设国际业务每月费用为250美元，得出1700万支多剂量注射笔。在美国，Wegovy以单剂量注射笔销售（每月4支注射笔 vs. 多剂量每月1支注射笔），因此2025年1300万张处方对应约5100万支注射笔，导致注射笔总数为6800万支。将美国Wegovy转换为等效多剂量注射笔数量，将得出2025年Wegovy的多剂量注射笔总量为3000万支。因此，我们估计，要满足诺和诺德当前的全球司美格鲁肽市场，需要约1.28亿支多剂量注射笔。

图表8：MS估计——满足先前司美格鲁肽需求所需的注射笔数量

假设美国Wegovy使用多剂量：

来源：MS

图表9：诺和诺德自2021年12月以来的原料药/灌装与封装投资——包括Catalent在内的灌装与封装投资达180亿美元

来源：诺和诺德

来自仿制药和CDMO关于注射笔/灌装与封装产能的评论很少，行业现有产能也难以评估，但我们认为需要更多投资来供应全球市场。与仿制药生产商合作的最活跃的灌装与封装公司是OneSource Specialty Pharma，该公司为Dr Reddy's（加拿大）和Apotex（加拿大/美国）提供灌装与封装服务。该公司目前正在执行一项1亿美元的投资计划，将其总药械组合卡式瓶产能从每年4000万支扩大到2.2亿支，扩张由全球市场对司美格鲁肽仿制药灌装与封装的预期需求驱动（仅部分产能分配给司美格鲁肽）。Gland Pharma是另一家投资建设灌装与封装产能以服务仿制药行业的公司，该公司计划到2027财年将约2000万支注射笔和卡式瓶用于GLP-1产品的商业化，并已投资将其总卡式瓶灌装与封装产能提高到2026年的1.4亿支。我们注意到，一些最大的灌装与封装供应商（如赛默飞、Simtra和Vetter）不太可能与司美格鲁肽仿制药生产商合作，因为它们倾向于将产能保留给利润率更高的创新药/复杂项目。

来自注射笔/卡式瓶/设备制造公司的评论表明，投资正在增长，注射笔产能正在提升。从注射笔/设备制造商的评论来看，Shaily Engineering Plastics（为Dr Reddy's加拿大仿制药以及Apotex美国和加拿大仿制药供应注射笔）最近整合了一条2500万支注射笔的产能线，专门用于司美格鲁肽。该公司还宣布投资在阿布扎比建设新工厂，生产7500万支注射笔；并预计到2028年3月达到每年1.5亿支的总注射笔产能（尽管并非所有产能都将专门用于司美格鲁肽仿制药）。主要的注射笔/设备制造商，如SHL medical、Ypsomed、Medmix、Nemera、Gerresheimer、BD、Schott Pharma、Phillips Medisize等，也为GLP-1供应链提供注射笔/卡式瓶，并可能被整合到仿制药灌装与封装供应链中。这些公司中的大多数已宣布产能扩张计划（通常超过1亿美元），至少部分由GLP-1疗法的需求驱动。

以Stevanato（由Kallum Titchmarsh覆盖）为例，该公司为GLP-1提供给药系统。GLP-1收入约占STVN公司总收入的19%–20%，较2024年增长超过50%。我们估计约90%

STVN的GLP-1业务为品牌业务，约10%来自除两大品牌生产商（诺和诺德和礼来）以外的参与者。Nexa注射器是STVN在2025年增长最快的产品，主要受GLP-1需求驱动。该公司的策略是同时覆盖原研药和生物类似药，并指出从历史经验看，当产品专利到期时，约70%的收入留在原研药方，30%流向生物类似药。

## 加拿大仿制药市场形成（2026年）

我们估计加拿大现有GLP-1市场规模约为20-25亿美元，其中司美格鲁肽约为15-20亿美元。诺和诺德报告2024年加拿大司美格鲁肽销售额约为11.5亿美元（Ozempic为10亿美元，Wegovy为1.5亿美元）。虽然诺和诺德未披露2025年加拿大司美格鲁肽销售额，但我们估计销售额约为16亿美元。这与Dr Reddy's管理层基于IQVIA数据对加拿大现有司美格鲁肽市场约18亿美元的估计一致。包括Mounjaro销售额（未披露，2023年11月上市，2025年5月全面供应），我们估计加拿大专利到期前市场规模约为20-25亿美元。

我们认为加拿大是专利到期后美国和欧洲市场动态如何演变的蓝图。诺和诺德管理层表示，印度并非其他国家的合适蓝图。一个关键原因是仿制药上市前品牌GLP-1市场发展不足，Wegovy/Ozempic在印度的合计销售额仅约5000万美元，原因是供应限制（Wegovy于2025年6月上市，Ozempic仅于2025年12月上市，尽管Rybelsus于2022年上市）和可负担性障碍。因此，仿制药生产商在品牌市场建立之前就已进入印度，迫使诺和诺德在仿制药上市背景下降价以保持竞争力。第二个关键点是印度与西方市场的平均收入差异，使得可负担性和价格在该国成为更突出的焦点。第三个关键点是印度获批的大量本地参与者（该国专利到期时有13家以上公司获批）带来的更激烈价格竞争。相比之下，加拿大在监管要求、平均收入和品牌GLP-1市场成熟度方面与美国和欧洲更为相似（加拿大是全球第二大GLP-1市场）。

Dr Reddy's和Apotex的产品是加拿大首批获批的两种司美格鲁肽仿制药。两家公司均获批生产多剂量2mg和4mg注射笔（对应1.0mg/周Ozempic剂量），且仅获批用于糖尿病适应症。两种产品的原料药均通过固相合成化学（即纯化学工艺，而非诺和诺德的混合生物/化学工艺）生产。Dr Reddy's（2026年4月28日获批，2026年5月16日上市）的仿制药原料药为内部生产。Apotex（2026年5月1日获批，2026年5月14日上市）的仿制药是与Orbicular Pharmaceutical Technologies合作开发；原料药来源未知，但我们认为可能由Orbicular CMO网络供应。Apotex和Dr Reddy's的灌装和封装均由OneSource处理，设备组件由Shaily Engineering Plastics提供。Apotex的司美格鲁肽仿制药（与相同合作伙伴开发和制造）也在美国获得了暂时批准。

Hims & Hers（由Craig Hettenbach覆盖）已与Apotex合作，在加拿大复制美国成功的消费者主导模式。H&H已宣布通过其平台推广Apotex仿制药用于减肥，尽管仿制药标签适应症仅限于2型糖尿病。H&H提供起价为149加元/月（107美元/月）的治疗方案，并延续了公司于2025年12月宣布的对Livewell的收购。Livewell成立于2023年，是一个专注于减肥、戒烟和性健康的远程医疗平台，此次收购专门旨在与加拿大司美格鲁肽仿制药上市的时间线保持一致。H&H新闻稿指出：司美格鲁肽仿制药已获加拿大卫生部授权用于2型糖尿病管理。在持牌医疗保健提供者的独立临床判断下，可超说明书用于体重管理。Hims & Hers Canada Inc.目前不提供2型糖尿病治疗服务。鉴于风险回报平衡，我们对HIMS维持等权重评级，面临利润率压力和核心增长放缓，而国际增长和新品类爬坡存在潜在上行空间（参见《更高收入指引伴随成本，EBITDA因利润率下降被削减》）。

我们预计Ozempic在公共报销渠道的价格将从约150美元/支（视地区而定）在短期内降至70-80美元，然后在第三个仿制药进入后降至约50美元。加拿大第三个仿制药的上市将触发所有Ozempic仿制药在报销渠道的价格下调。加拿大的仿制药公共报销/挂牌价格通过泛加拿大制药联盟（pCPA）仿制药分级定价框架设定。当两种仿制药上市时，仿制药价格设定为品牌参考价的50%；当第三种仿制药上市时，将自动触发报销/挂牌价格层级变更，仿制药价格设定为品牌参考价的35%（针对注射剂）。虽然诺和诺德无需将品牌Ozempic价格降至仿制药水平，但该药物为保持对仿制药的竞争力，很可能大幅降价。我们还注意到，虽然加拿大私人计划无需遵循pCPA价格，但许多计划确实遵循，这实际上导致公共价格溢出至私人市场。

加拿大卫生部目前正在审查其他四家仿制药生产商的仿制药，预计未来几个月将有更多公司提交申请。除已获批的Apotex和Dr Reddy's两种仿制药外，加拿大卫生部目前正在审查另外七种仿制药，其中三种是Apotex的额外

申请，另外四种来自Sandoz、Teva、Taro和Aspen。Aspen表示预计在2026年5月至9月间获批；Sandoz预计在2026年下半年获批；Teva和Taro尚未发表评论。另有另外三家公司也在加拿大开发司美格鲁肽仿制药，但根据加拿大卫生部披露，尚未提交申请：PharmaTher（目标2026年获批）、Biocon以及加拿大公司Vimy Pharma，该公司正寻求将加拿大合作伙伴生产的西林瓶仿制药推向市场。

图表10：加拿大司美格鲁肽仿制药新兴格局

来源：MS、公司披露、加拿大卫生部

**加拿大仿制药影响建模：**我们建模Ozempic价格从仿制药进入前的150美元/月下降至2027年的约50美元/月，随后几年进一步降至25美元/月。我们假设GLP-1在糖尿病和超重/肥胖人群中的渗透率从2025年的约7%增至2035年的约25%，其中Ozempic及仿制药占16.5%。我们假设仿制药生产商长期占据Ozempic 80%的销量。这将导致诺和诺德Ozempic/Wegovy销售额从2025年的16亿美元降至2035年的约2.8亿美元。我们的模型显示，2026年加拿大仿制药进入对集团销售额的影响为-1%，与诺和诺德关于所有国家（其中加拿大是最大的）专利到期对集团销售额影响为低个位数百分比的评论一致。

图表11：加拿大Ozempic/Ozempic仿制药市场建模

资料来源：MS估计

## 印度仿制药市场形成（2026年）

- ICMR-INDIAB（2023年）：印度糖尿病患病率为11.4%；40%的成年人患有腹型肥胖，1.36亿人处于糖尿病前期。根据全国家庭健康调查-5，15-49岁年龄段的印度人中，近四分之一现在超重或肥胖。
- 2026年3月专利到期后，司美格鲁肽销量激增（约6倍），仿制药占据了可注射司美格鲁肽的很大份额；原研药企销量稳定表明增长是由新患者增加驱动的，而不仅仅是转换用药。
- 我们预计印度GLP-1市场将在2030年达到966亿卢比（10亿美元）。
- 截至2026年4月，Torrent、DRL、Zydus和Sun已成为仿制司美格鲁肽的主要参与者。
- 一些印度企业正在内部生产原料药，并积极规划后向整合。除印度市场外，Dr Reddy's还获得了加拿大批准，目标是到FY28年产量超过4000万支笔。Divi's旨在成为全球多肽领域最大的参与者之一，目前拥有印度最大的SPPS规模（固相多肽合成，即多个约3000升反应器），我们相信该公司是礼来供应链的一部分。One Source Specialty和Shaily Engineering等CDMO计划将产量提高4-5倍，而Anthem Biosciences计划生产司美格鲁肽原料药。

我们认为司美格鲁肽专利到期是一个转折点，它将印度的GLP-1市场从一个高端的、可及性受限的类别转变为一个大众市场的、销量驱动的细分市场。2026年3月后的早期数据显示，在仿制药的推动下，销量急剧加速，可负担性释放了富裕城市群体以外的需求，并扩大了在一线和二线城市的采用。

中期来看，我们看到：1) 扩张阶段（未来12个月）市场继续扩张，未来几个月将有更多参与者进入市场。2) 少数规模化参与者之间的整合阶段，特别是那些具有后向整合、器械能力和分销优势的参与者。3) 细分：GLP-1市场出现明显细分，司美格鲁肽锚定大众市场销量增长，而礼来的Mounjaro/替尔泊肽保持高端定位。

总体而言，我们预计印度GLP-1市场将从FY26的1.66亿美元急剧增长至FY30的10亿美元（图表13），主要受仿制药驱动的渗透率增长推动。关键的投资争论从“市场能有多大”转变为“在销量驱动、价格竞争激烈的环境中谁能获取价值”，成本、供应链整合以及品牌/分销方面的执行力成为关键的差异化因素。

图表12：全球20-79岁年龄组糖尿病患病率（百万人）

资料来源：IDF糖尿病地图集第11版 - 2025年，MS

图表13：2024年各国（20-79岁）糖尿病患病率 前5个国家

资料来源：IDF糖尿病地图集第11版 - 2025年，MS

印度GLP-1市场

专利到期前：礼来的Mounjaro于2025年3月上市并迅速放量，反映出尽管定价高昂但需求强劲。到FY26末（2026年3月31日），它成为印度最畅销的品牌药，FY26年销售额为98亿卢比（1.11亿美元）。诺和诺德的Wegovy/Ozempic（司美格鲁肽）最初因定价和供应限制而采用速度较慢，但在价格合理化和分销合作后获得了增长动力。FY26整个GLP-1市场规模为1.66亿美元。

仿制司美格鲁肽上市后，市场已经扩大，4月份的年化销售额意味着市场规模为2.75亿美元，其中仿制药份额为20%。随着仿制司美格鲁肽的出现，我们预计可负担性将显著改善，将采用范围从富裕的城市群体扩大到一线和二线城市。

4月是专利到期后的第一个月，早期迹象表明：

- 替尔泊肽（FY26为1.04亿美元）仍是主导分子。Cipla（与礼来合作）的份额在峰值时已扩大至约10-13%，礼来的市场份额为63%
- 诺和诺德仍是第二大参与者，市场份额约为19-25%，由其司美格鲁肽系列产品（Ozempic/Wegovy/Rybelsus）支撑 - 见图表19。图表19
- 增长由销量驱动，仿制药推动单位销量跃升2-3倍，注射剂激增约6倍，而价值增长（低于2倍）因价格侵蚀而滞后，凸显了可及性驱动的扩张。
- 注射剂表现优于口服药 - 见图表24。

图表14：印度GLP-1市场模型

资料来源：Pharmatrack，MS估计（e），所有期间美元/印度卢比汇率为95

展望：短期内，GLP-1市场处于超增长阶段，2026年4月势头强劲，且持续有激进的上市活动；而中期来看，随着竞争加剧，增长应会放缓，整合开始出现；监管行动可能会遏制滥用，但不太可能破坏结构性增长轨迹。总体而言，我们预计印度GLP-1市场将从FY26的1.66亿美元急剧增长至FY30的约10亿美元，主要受仿制药快速采用推动。

图表15：印度GLP-1市场（百万美元）

资料来源：Pharmarack，MS，整个期间美元/印度卢比汇率为95

图表16：印度GLP-1市场（百万卢比）

资料来源：Pharmarack，MS

图表17：印度GLP-1市场份额（FY26）

资料来源：Pharmarack，MS

图表18：印度GLP-1市场份额（26年4月）

资料来源：Pharmarack，MS

图表19：

前10大参与者的GLP-1市场份额

资料来源：Pharmarack，MS

图表20：各参与者仿制药定价

资料来源：Tata 1 mg, MS, 更新于2026年6月5日, 美元/印度卢比汇率为95

图表21：司美格鲁肽市场份额（百万美元）

资料来源：Pharmarack, MS, 美元/印度卢比汇率为95

图表22：司美格鲁肽市场份额（百万卢比）

资料来源：Pharmarack, MS

口服司美格鲁肽：

迄今为止，我们看到了两次Rybelsus仿制药的上市。2026年3月21日，Torrent以品牌名'Semalix'和'Sembolic'推出了司美格鲁肽（口服片剂）3mg、7mg和14mg。该品牌4月份销售额为6000万卢比（60万美元）。2026年5月20日，DRL成为第二家以品牌名Obeda推出口服片剂的公司，这些片剂也具有相似的规格（3mg、7mg和14mg）。DRL的定价比Torrent更激进，因此Torrent降低了价格以接近DRL。我们预计未来几个月将有更多参与者推出口服片剂。事实上，Torrent在其F4Q26财报电话会议上补充说，它预计口服市场将是注射剂市场的20%-30%。

图23：司美格鲁肽口服 vs 注射剂市场（百万美元）

资料来源：Pharmarack, MS

图24：司美格鲁肽口服 vs 注射剂市场（百万卢比）

资料来源：Pharmarack, MS

图25：司美格鲁肽价值市场份额

资料来源：Pharmarack, MS

在司美格鲁肽仿制药上市后，司美注射剂用量急剧攀升，从2026年2月的2.5万支增至3月的6.3万支和4月的16.9万支，主要受仿制药快速放量推动（3月4万支增至4月13.7万支）。这意味着仿制药目前约占司美注射剂总用量的80%，增长主要由市场扩张而非纯替代驱动，因为原研药用量基本保持稳定（3月2.3万支增至4月3.2万支）。放量规模也使得司美格鲁肽在用量上超越替尔泊肽（4月16.9万支 vs 8.2万支），强化了司美作为大众放量产品与替尔泊肽高端定位的对比。总体而言，早期趋势支持专利到期后以用量为主导的采用阶段，对原研药需求的直接冲击有限，但向仿制药的明确且快速的结构转变已经出现。

图26：司美格鲁肽与Mounjaro用量

资料来源：Pharmarack, MS

印度供应链动态

仿制药入局规模：专利到期引发了约13家以上仿制药企业的进入，价格下降70 – 80%。司美格鲁肽仿制药月费用低至14美元（约1,290卢比）。

后向整合与规模：最初大多数公司进口原料药。少数公司如Dr. Reddy's和太阳制药正在投资全供应链控制，自主生产司美格鲁肽原料药并快速扩大产能。印度CDMO，包括OneSource Specialty，正在进行显著的产能扩张计划，目标到2027年产量增加约4 – 5倍（例如，Dr. Reddy's从2026年约700万支增至2028财年超过4000万支，灌装与封装由OneSource管理）。根据其2025财年年报，OneSource计划将卡式瓶产能从2025财年的4000万支扩大到2028财年的约2.2亿支。

印度仿制药公司采取了不同的原料药采购策略：

- Dr. Reddy's Laboratories (DRL)：完全后向整合的最显著案例。DRL完全自主生产司美格鲁肽原料药，成品制造由其制造合作伙伴OneSource Specialty Pharma Limited完成。DRL预计其司美格鲁肽产能将在2026年达到约600 – 700万支，2028财年产能可能超过4000万支。

- Torrent Pharma：口服制剂自主开发，Semalix和Sembolic的原料药均来自DRL。注射剂方面，外包模式因产品而异；Semalix预填充笔来自DRL，而Symbolix笔来自Zydus。
- 太阳制药：太阳制药自主生产司美格鲁肽原料药。Noveltreat和Sematrinity的预填充笔由欧洲领先的全球制药设备供应商制造。
- Lupin：与西班牙公司Galenicum合作成品制剂，Galenicum负责开发、制造和供应，Lupin负责23个国家的注册申报和商业化。
- Shilpa Medicare：正在开发司美格鲁肽的合成和半合成原料药，原料药验证批次正在进行中，制剂开发（注射剂和口服固体制剂）已完成。
- MSN Laboratories：已垂直整合司美格鲁肽生产，自主制造原料药和注射笔装置。
- Biocon：自称在司美格鲁肽方面实现"垂直整合"，向Ajanta Pharma（印度）供货，在26个国家进行销售。

## 与原研药企的合作

- Cipla：2025年10月23日，礼来与Cipla签署了替尔泊肽在印度的第二个品牌的营销和分销协议。Cipla于2025年12月10日推出Yurpeak（替尔泊肽），成为礼来替尔泊肽在印度市场上第二个品牌，与Mounjaro并列。
- Emcure Pharma：2025年12月22日，在印度推出Poviztra（司美格鲁肽注射液），根据与诺和诺德的独家合作，成为首家分销和商业化第二个司美格鲁肽品牌用于体重管理的印度公司。
- Abbott India：2026年2月，雅培与诺和诺德合作在印度营销和分销司美格鲁肽（全球商品名为Ozempic），雅培将其以Extensor品牌商业化，以扩大先进糖尿病治疗的覆盖范围。

## CDMO公司

- Divi's Labs（为原研药企生产）：该公司目前拥有印度最大的固相肽合成规模（即多个约3,000升反应釜）。它为SPPS肽类药物生产片段和氨基酸。
- One Source Specialty：该公司是一家纯业务专业制药CDMO，专注于复杂的药械组合产品。它不生产司美格鲁肽原料药，但为自带原料药的制药合作伙伴提供端到端的制剂、灌装与封装以及装置组装服务。
- Anthem Biosciences：Anthem是印度后向整合程度最高的司美格鲁肽原料药制造商，自主生产发酵片段（P29前体）和化学合成步骤，使其成为印度少数能做到这一点的公司之一。这使其在与中国原料药供应商竞争时具有显著的成本优势。
- Shaily Engineering：Shaily Engineering Plastics是一家给药装置制造商，为司美格鲁肽设计、开发和制造注射笔和自动注射器。它不生产原料药或制剂。其专有平台包括ShailyPen Neo（弹簧驱动，可变和固定剂量）和Shaily Harmony。
- Gland Pharma：Gland为其制药合作伙伴提供的原料药灌装卡式瓶，涉及三种GLP-1产品，即利拉鲁肽、司美格鲁肽和替尔泊肽。

图27：印度主要制药公司关于司美格鲁肽和GLP-1的关键评论

资料来源：公司数据，MS

## 巴西市场形成（2026年）：司美格鲁肽专利到期为正式市场扩张奠定基础

### 仿制药上市前的现状：GLP-1的可及性主要受 affordability 限制

巴西的GLP-1市场渗透率仍然严重不足，原因并非需求疲软，而是在一个几乎完全自费的市场中，affordability持续制约着 adoption。目前主流GLP-1疗法的月治疗成本仍在约R\$800至R\$1,600（每月160至320美元）之间，这一价格水平将可及性限制在狭窄的高收入阶层，并使渗透率远低于市场潜在的临床需求。对复方替代品和未经

授权进口产品的需求规模进一步印证了这一 affordability 瓶颈，表明许多患者正在正规市场之外积极寻求更低成本的获取途径，而非完全放弃治疗。如今，供应限制似乎不那么普遍，但Mounjaro/tirzepatide的供应仍不稳定，即使在可触及的高收入群体中，反复出现的缺货仍可能限制实际销量。因此，根据我们2026年第一季度的估算，巴西目前仅有约210万活跃GLP-1用户（占当前成年人口的1.3%），这突显了在一个品类渗透率远低于潜力的大型新兴市场中，存在大量未满足的需求。

## 早期的定价动向表明现有企业已在为司美格鲁肽的竞争做准备

我们还观察到Eurofarma对司美格鲁肽授权仿制药的一些初步折扣和降价，详见《拉美医疗：GLP-1巴西追踪：4月进口量环比下降但仍稳健；ANVISA新数据带来洞察》（2026年5月7日）。这些举措对整体市场动态仍微不足道，因为价格点仍然过高，无法实质性扩大可及性或引发品类渗透率的显著转变。然而，它们在方向上很重要：早期的折扣表明，诺和诺德-Eurofarma的合作关系已在为更广泛的司美格鲁肽仿制药上市前的竞争做准备，随着更多获批替代品进入市场，定价可能成为更相关的竞争杠杆。

## 2026年的仿制药主导转型：价格重置与 adoption 加速的开端

随着司美格鲁肽仿制药预计于2026年下半年上市，我们预测GLP-1的可及性将因 affordability 改善而显著扩大，尽管市场可能需要到2026年以后才能达到专利到期后的均衡。司美格鲁肽仿制药已被推迟，首个批准（针对EMS产品）于2026年5月获批，计划于6月15日上市；因此我们正在模拟2026年下半年的市场形成；详见《拉美医疗与教育：我们在巴西杂志HC大会上的观点》（2026年4月28日）。一旦首批品牌仿制药上市，司美格鲁肽价格应开始逐步下降，我们预测到2026年底，司美格鲁肽仿制药价格将达到约R\$687/月（137美元/月），而目前诺和诺德产品（Ozempic和Wegovy）的价格约为R\$1,000/月（200美元/月）。我们估计2026年GLP-1市场总销售额约为R\$143亿（25亿美元），到2026年底活跃用户将增至约340万，因为更低的入门价格使销量能更好地反映潜在需求。话虽如此，2026年仍应被视为加速年而非稳态，随着更多进入者、持续的价格压缩以及更广泛的 affordability 提升可能在2026年底逐步显现，到年底渗透率仍将低于长期潜力。

## 专利到期后的转变：司美格鲁肽仿制药解锁可及性的阶跃变化与市场稳定

在2026年的初步调整之后，司美格鲁肽的专利到期可能推动巴西GLP-1市场的结构性转变，因为在一个收入分配悬殊的国家，更低的价格将解锁显著更广阔的可及人群。我们预计多种仿制药的进入将导致月治疗成本累计下降约70%，司美格鲁肽在专利到期后达到R\$294/月（59美元/月）（见图表28）。在这一价格点，affordability 显著扩展到中等收入家庭，将GLP-1的可及性从高收入利基市场转向更广泛的大众市场疗法。我们估计，专利到期后，可及的GLP-1人群将扩大到约1700万潜在用户（见图表29），Mounjaro和未来礼来产品可能集中在高收入群体，而司美格鲁肽则成为巴西庞大的B2-C收入阶层的首选。随着 adoption 的扩大，我们预计GLP-1市场将在2026年后继续增长，2027年达到约R\$206亿（34亿美元），2029年达到约R\$309亿（43亿美元），并稳定在约R\$390亿（51亿美元）的长期机会附近，这主要受价格弹性和更强的消费者支付意愿驱动，而非潜在肥胖患病率的变化（见图表30）。

图表28：司美格鲁肽平均价格演变（巴西雷亚尔/单位）

来源：IQVIA，MS估算（E）

图表29：GLP-1潜在客户群（排除已治疗患者；千人）

来源：IQVIA，Nexo Journal（月薪排名），IBGE，及MS估算（E）

图表30：GLP-1销量演变（单位；千）

来源：IQVIA，Nexo Journal（月薪排名），IBGE，MS估算（E）

图表31：GLP-1市场（十亿巴西雷亚尔；购买力平价）

来源：IQVIA，Nexo Journal（月薪排名），IBGE，MS估算（E）

## 本土生产商可能是专利到期的最大受益者

专利到期后的司美格鲁肽市场应由全球仿制药生产商（主要来自印度和中国）与本土企业的合作伙伴关系塑造。在这一格局中，非上市家族企业EMS作为唯一的国内生产商脱颖而出，很可能处于从司美格鲁肽专利到期中获益的最佳位置，其合成司美格鲁肽笔Ozivy于5月26日成为首个获得Anvisa批准的产品（见此处，仅葡萄牙语）。该公司已投资于本地GLP-1生产能力，据报道，利拉鲁肽和司美格鲁肽的年产能约为2000万支注射笔。我们认为，这种本地化布局可能赋予EMS成本优势，因为它不依赖与外国制造商的特许权使用费合作关系。巴西政府于3月26日决定将EMS注射笔所用组件的进口关税从14.4%降至0%，为期一年，配额高达3000万单位，这应进一步支持随着产量扩大而实现的竞争性定价。获批后，CMED设定的最高价格与Ozempic相当；然而，EMS宣布零售价为452巴西雷亚尔，在该公司的折扣计划下，三个月疗程的价格可能达到287巴西雷亚尔（57美元）（见此处，仅葡萄牙语）。展望未来，如果EMS成功扩大生产规模，它可以通过正规渠道扩大可及性，并将自身定位为专利到期后司美格鲁肽领域的领先低成本生产商。

11/15

潜在新进入者：EMS之外更广泛的竞争管线。尽管EMS是继Ozivy获得Anvisa批准后的先行者，但随着更多参与者推进监管审批流程，专利到期后的司美格鲁肽市场应会日益拥挤。据G1报道（见此处，仅葡萄牙语），Anvisa有17项司美格鲁肽相关申请正在处理中，其中8项已在分析中，3项处于高级阶段，等待公司对Anvisa技术问题的答复。随着EMS获批，我们认为这些高级申请中可能有一项是Ozivy，但更广泛的管线仍然意义重大。在这些公司中，公开报道指出了潜在竞争者，包括Hypera、Biommm（通过其与Biocon的协议），以及Cimed、Prati-Donaduzzi（见此处，仅葡萄牙语），可能还有Sandoz，据报道后者已将巴西确定为2026年初仿制司美格鲁肽的早期目标市场之一（见此处）。我们认为，EMS可能获得先发优势，但中期市场结构应会演变为多参与者的品牌司美格鲁肽仿制药格局，竞争将由审批时间、CMED定价、注射笔供应、本地分销覆盖、医生关系以及资助患者折扣计划的能力所驱动。

对诺和诺德专利到期后的影响：巴西作为美国以外市场侵蚀的早期测试案例。巴西是诺和诺德在专利到期后司美格鲁肽动态的首批大型新兴市场测试之一，而EMS的Ozivy近期获批表明仿制药审批周期现已开始启动。尽管延迟的审批过程给了诺和诺德更多时间来捍卫其专营权，但结构性风险正变得更加切实：随着获批的合成司美格鲁肽产品进入市场，诺和诺德可能面临价格侵蚀、销量份额稀释以及来自拥有强大分销、处方关系和零售覆盖的本地参与者的竞争加剧。关键争论在于，随着司美格鲁肽的可及性从高端小众市场向更大众化的治疗领域扩展，诺和诺德能保留多少不断扩大的市场份额。我们认为，应关注巴西，将其作为诺和诺德在美国以外更广泛专利到期逆风的早期指标，尤其是在可负担性限制高、本地仿制药能力强、且需求已通过非正规和复方药房渠道显现的市场。

对我们覆盖范围的影响：司美格鲁肽的专利到期对RADL（超配）和HYPE（超配）均应构成利好，尽管机制不同。对于RADL，主要上行空间在于可寻址市场的扩大，因为较低的司美格鲁肽价格将GLP-1的可及性从狭窄的高收入小众群体拓展出去，同时目前由未经授权的进口和复方替代品所服务的需求将迁移至正规药房渠道。虽然较低的价格可能对平均客单价构成压力，但弹性应能支撑更高的销量、客流量和重复处方需求，而RADL凭借其全国性布局、数字化能力、供应商关系以及销售品牌和仿制GLP-1的能力，处于有利地位以抓住这一转变。对于HYPE，机会更依赖于执行，但可能意义重大：如果公司及时获得Anvisa批准并在早期几波品牌司美格鲁肽仿制药中推出，它可以直接参与一个需求已经存在、但部分仍因价格因素被排除在合法渠道之外的市场扩张和正规化进程。EMS的先发优势和本地制造能力是相关的竞争障碍，但市场应会演变为一个多参与者的品牌仿制药细分市场，随着司美格鲁肽从高端小众市场转变为更广泛的大众化治疗领域，HYPE的医生关系、营销能力、零售覆盖和品牌建设能力可支撑其获得份额增长。

我们预测的风险：未经授权的进口和复方GLP-1凸显了未满足的需求，但也带来了监管和安全风险。复方、非正规和跨境GLP-1渠道的出现是另一个信号，表明潜在需求超出了正规市场当前的可负担能力曲线。在仿制药进入之前，人们预期低成本替代品会降低平均价格并扩大可及性，但平行市场的规模表明，即使在正规的司美格鲁肽仿制药到来之前，低收入消费者的需求已经存在。作为参考，根据RADL 2026年第一季度的电话会议，非官方GLP-1市场的规模可能是官方市场的3-4倍。展望未来，一个关键催化剂将是对未经授权的进口和复方替代品加强执法，这可能会对黑市供应构成压力，而获批仿制药的较低价格应鼓励消费者转向合法市场。

## 中国市场形成（2027年）

尽管中国的GLP-1市场远小于美国，但它拥有显著的肽类原料药产能，这是一系列偶然条件的结果。

中国目前的GLP-1市场与美国市场相比规模较小：2025年，中国GLP-1市场总额仅为81亿元人民币（约11亿美元），同比增长27%。近90%的市场来自司美格鲁肽（IQVIA），仅为2025年美国市场（520亿美元[同样来自IQVIA]，同比增长37%）的一小部分。部分原因在于品牌药的获批日期较晚以及报销水平较低。自2010年以来在中国推出的10个GLP-1品牌中，大多数比美国晚数年推出，包括诺和泰（3.5年）和诺和盈（3年），而穆峰达在糖尿病适应症上比美国晚2年推出。

图表32：中国GLP-1的获批时间滞后于美国

注：替尔泊肽用于肥胖症在美国以Zepbound销售，在中国以穆峰达销售，用于糖尿病和肥胖症。来源：国家药监局；美国食品药品监督管理局；MS。

图表33：中国GLP-1报销状况——仅糖尿病适应症可报销

来源：国家药监局；MS

中国的灰色/非官方渠道规模庞大。这个市场包括在线销售、假冒产品以及原料药销售。中国当局近几个月来加大了对GLP-1无证生产和销售的打击力度；例如，从5月中旬开始，药房需要顾客提供医院纸质处方才能配发GLP-1药物。尽管中国的官方市场规模较小，但可寻址市场的很大一部分迄今已通过非官方渠道流失。

12/15

礼来在本地CDMO支持下推出的新产品，有望在仿制药上市前推动市场增长。替尔泊肽（Mounjaro）今年初刚被纳入国家医保目录，因此（在价格让步后）今年销量有望扩大。礼来即将推出的口服GLP-1药物Foundayo（orforglipron），也可能凭借差异化的便利性推动市场接受度。2026年初，礼来与中国CDMO康龙化成合作供应Foundayo（注）；我们注意到，康龙化成位于北京的固体制剂工厂年产能可为10-20亿片。该工厂可能专门用于生产该药物，这表明其市场潜力巨大（注）。中国领先的CDMO药明康德也一直是礼来的长期全球合作伙伴。

司美格鲁肽的专利于2026年3月在中国到期。司美格鲁肽的化合物专利于2006年3月提交；根据WTO设定的20年专利期限，该专利将于2026年3月在中国到期，早于美国和欧盟（诺和诺德在这些地区利用了特定的专利期限延长机制）。在2021年6月中国政府引入类似美欧模式的延期机制之前，中国不存在此类机制。司美格鲁肽（诺和泰）于2021年4月在中国首次获批用于糖尿病适应症，因此刚好错过了延期路径的颁布时间。

然而，根据《中瑞自由贸易协定》，其独占期可能延长至2027年4月。诺和诺德于2021年4月在中国通过其瑞士注册实体诺和诺德制药股份公司提交申请，获得了司美格鲁肽的批准。2014年，中国与瑞士签署了《中瑞自由贸易协定》，这是一项双边经济条约，旨在减少贸易壁垒、改善市场准入并加强知识产权保护。在知识产权保护方面，两国对未公开的药品试验数据给予自药品获批之日起（即司美格鲁肽在中国为2021年4月）六年的市场保护。当专利于2026年3月到期时，诺和诺德援引了这一特定条款，阻止仿制药在中国上市直至2027年4月。由于该条款，在此之前，仿制药申请人在其监管申报中不得使用诺和诺德的试验数据。杭州九源基因于2026年1月在浙江省法院对该条款提出质疑；但截至撰写本文时，中国尚无仿制药获批。

预期到司美格鲁肽专利到期，众多中国开发商已纷纷准备提交生物类似药申请。这些企业包括复星医药和中国生物制药（正大天晴）等大型制药公司，以及联合实验室和华东医药等专业公司（专注于糖尿病或胰岛素/多肽领域）。排队申请中的大多数是针对糖尿病适应症。该竞赛中的领跑者之一华东医药在5月底的股东大会上表示，由于《中瑞自由贸易协定》，其司美格鲁肽仿制药要到2027年4月之后才能上市，从而确认了延期的有效性。与此同时，hybio（翰宇药业）最近也提交了生物类似药申请（与华润双鹤合作开发），并预计将作为原料药供应商。

图表34：中国国家药监局已受理审评的司美格鲁肽生物类似药

来源：国家药监局；MS

## 礼来相关考量

### 礼来注射用肠促胰素供应前景

在峰值时，我们估计礼来目前的注射平台（自动注射器 + KwikPen）可提供约1000亿美元的总销售产能，基于我们最新的假设，美国/美国以外地区每张处方的收入分别为360美元/195美元，同时服务全球约2500万患者（图表35）。西林瓶提供了另一个供应节点（但我们对此处的产能了解有限），礼来也可以选择进行未来投资以建设额外的注射产能。话虽如此，我们认为，为了使GLP-1药物在美国市场达到类似他汀类药物的渗透水平，鉴于注射产能的限制，口服药物（如Foundayo）可能是必需的（见此处）。

图表35：礼来肠促胰素注射平台预估峰值销售额（千张处方/千人）

来源：MS；注：美国定价假设基于Mounjaro/Zepbound联合产品线的峰值销售收入（我们模型中的2031年）。我们假设两个产品之间的收入分成约为50%/50%，以得出图表中使用的平均自动注射器定价。

我们此前估计，礼来可通过利用现有过剩产能生产约5500万支KwikPen（服务约460万患者/年）（见下方图表36）。虽然我们提醒，我们对礼来美国以外地区的销量以及礼来的过剩产能数量了解有限，但我们相信我们的估算表明，即使采用比我们当前假设更为保守的假设，礼来也能大幅提高其当前的生产水平。我们认为，鉴于注射剂因注射装置的灌装和封装而面临的供应限制，口服药物将成为市场增长的关键因素。此外，在任何药物市场中，总有一部分患者更倾向于药片而非注射剂，我们预计肥胖症领域也将如此。

请参阅我们此前关于礼来供应增长的报告《GLP-1供应图谱》。

图表36：礼来KwikPen产能估算

来源：MS估算、公司数据、IQVIA

2026年3月11日，礼来表示计划未来十年在中国投资30亿美元，以扩大本地供应链产能，包括建立口服固体制剂的本地化生产（链接）。该投资将主要用于支持Foundayo（口服GLP-1药物）的生产，礼来中国已于2025年底向国家药监局提交了该药用于肥胖症和2型糖尿病的上市申请。礼来指出，目前其在中国的累计投资总额已达约60亿美元，涵盖心血管代谢健康、神经科学、肿瘤学和免疫学领域。我们认为，这项最新投资凸显了礼来对Foundayo在中国商业潜力的信心。

根据2024年第一季度财报评论，在美国以外地区，礼来最初使用注射器/西林瓶形式在特定市场推出Mounjaro（替尔泊肽），随后在获得英国和欧盟的初步监管批准后转为KwikPen形式（链接和链接）。随后KwikPen的推广扩展至德国、沙特阿拉伯和阿联酋，2024年第二季度财报业绩评论中披露了在西班牙的获批，随后在澳大利亚上市。截至2026年第一季度，Mounjaro已在超过55个国家全面上市，在巴西和韩国的市场接受度尤为强劲，估计市场份额达到约60%（关于特定国际市场推出时间的详细信息，请参见图表37）。

图表37：礼来GLP-1肥胖症产品线在美国以外地区的部分监管批准和上市情况

来源：公司数据、MS

### Mounjaro 2026年美国以外地区机遇

#### 我们近期基于历史市场份额增长以及GLP-1肥胖症药物采用/增长趋势的加速，对礼来美国以外地区的Mounjaro机遇进行了敏感性分析

（见此处）。基于我们对美国以外地区GLP-1/肠促胰素市场增长、处方趋势和区域份额动态的分析，我们看到我们对美国以外地区Mounjaro的预测存在上行空间，而该预测已经领先于市场共识预期（图表38）。

我们的分析表明，如果礼来能够维持当前的国际市场份额趋势，尤其是在全球肥胖症用药接受度加速提升的背景下，市场对Mounjaro海外销售的普遍预期可能仍显保守。同时，我们承认，由于欧洲以外地区的处方透明度有限（参见我们关于欧盟GLP-1处方的报告）、区域定价碎片化、报销框架不均衡，以及诺和诺德司美格鲁肽仿制药在印度和巴西等特定市场即将带来的潜在影响（上文已讨论），国际市场的可见度仍然受限。因此，尽管我们继续看好礼来肥胖症业务（包括口服Foundayo）在中长期内的海外机遇，但国际市场的季度预测本质上仍不如美国市场精确。

图表38：GLP-1注射剂海外历史销售额与礼来2026财年海外销售额预测

来源：MS预测；注：对2025年第一季度至2026年第一季度的GLP-1美国以外总销售额应用线性回归，以估算2026财年剩余时间。GLP-1市场总隐含计算包括诺和诺德的Ozempic、Wegovy、Rybelsus以及礼来的Mounjaro、Zepbound。

礼来表示，公司仍是全球肠促胰岛素市场的领导者，在国际市场占有约53%的份额，而在美国约为60%，并预计随着近期市场份额的 gains 开始稳定，将实现持续的同比强劲增长和“一些”环比增长。目前Mounjaro的海外组合中，约75%用于体重管理（主要为自费），25%用于2型糖尿病（主要获得报销）。管理层还强调了印度近期令人鼓舞的趋势，在那里，司美格鲁肽仿制药的上市扩大了品类认知度并产生了“光环效应”，据报道，尽管面临仿制药竞争，Mounjaro仍增长了约10%。在中国，Mounjaro自1月1日起被纳入国家医保药品目录，这造成了近期的定价压力，但可能支持2026年晚些时候更强劲的量增长。

图表39：诺和诺德 vs. 礼来在欧洲每周注射型GLP-1的价值份额

来源：IQVIA Global MIDAS

图表40：礼来视角下的国际肠促胰岛素类似物市场

来源：礼来2026年第一季度财报演示；注：数据来源：IQVIA GMI Agent AI, MIDAS Monthly，访问日期2026年4月29日；美国MNF：按销售时生效汇率计算的美元销售额；MNF：批发商采购价和制造商销售价；市场篮子：Bydureon/Byetta, Lyxumia, Victoza, Ozempic, Trulicity, Rybelsus, Saxenda, Wegovy, Mounjaro, Zepbound；地域：全球除美国和波多黎各。

图表41：礼来Mounjaro海外销售额及隐含的肥胖症/2型糖尿病拆分（首次海外肥胖症获批后）

来源：MS；注：2型糖尿病销售额使用基于2022年第四季度至2023年第三季度销售额的线性回归估算，即Mounjaro首次海外获批用于肥胖症之前。

图表42：礼来 vs. 诺和诺德GLP-1海外销售额及礼来市场份额

来源：公司数据，MS；注：1Q24指礼来肥胖症适应症的首次上市（阿联酋除外，该产品在上市时与2型糖尿病适应症同时使用）。详见图表35。欧盟市场份额代理计算假设5%的线性增长率，应用于从1Q24开始的2型糖尿病基线份额，以估算肥胖症增长。Mounjaro，表示为美国以外GLP-1总销售额的百分比，反映了诺和诺德销售额与礼来美国以外销售额的总和。

## 口服制剂的入场

我们近期更新了对肥胖症和2型糖尿病领域GLP-1格局演变的看法，刷新了我们的全球肥胖症模型和最新的GLP-1假设。我们持续看到GLP-1疗法的使用率在增长，并相信五个关键驱动因素可以支持未来全球渗透率的进一步提升：(1) 口服GLP-1疗法的上市（诺和诺德的Wegovy口服片和礼来的Foundayo），(2) 美国老年患者通过Medicare更广泛地获得所有GLP-1药物（自付费用为每月50美元），(3) 国际市场扩张（如中国和巴西，我们将详细讨论），(4) 下一代分子/通路，以及 (5) 在炎症和神经系统适应症等新疾病领域的临床获益。

我们认为，口服制剂，如诺和诺德的口服Wegovy片（口服肽类GLP-1，于2025年12月22日获批用于肥胖症）和礼来的Foundayo（口服小分子GLP-1，于2026年4月1日获批用于肥胖症），也将推动肥胖症市场的下一个转折点。在2025年第四季度财报电话会议上，礼来重申了其观点，即口服GLP-1的进入将扩大市场，诺和诺德在2025年

第四季度财报电话会议上的评论也支持了这一观点，该评论指出大多数口服Wegovy患者是肠促胰岛素初治患者。在我们最近的AlphaWise消费者调查中，77%的Wegovy口服片使用者是GLP-1疗法的新用户，这进一步支持了我们的观点，即口服制剂将大幅扩展该品类。在2026年第一季度，礼来表示，大量的库存积累预示着该药物即将在国际上推出，因为他们看到了Foundayo在全球的“巨大”机遇，这也与我们的观点一致。

在研的口服GLP-1疗法旨在提供现有注射剂的益处，同时为患者提供替代剂型，并且在某些情况下，在全球范围内实现更好的可扩展性。一个关键的科学挑战是，大多数肠促胰岛素是会在胃中迅速降解的肽类，这促使公司要么 (1)

设计口服肽递送系统，例如诺和诺德在Rybelsus/Ozempic口服片和Wegovy口服片中使用的SNAC递送平台，要么 (2) 开发非肽类小分子，例如礼来的Foundayo。口服肽制剂通常需要限制食物和水的摄入（例如，空腹服用，然后在进食、饮水或服用其他药物前等待一段时间）以促进吸收。结合生产方面的考虑，我们认为非肽类小分子最终可能被证明更具可扩展性和便利性。因此，我们认为礼来的Foundayo将随着时间的推移在海外市场发挥重要作用，同时注意到诺和诺德的口服Wegovy可能随着需求扩大而面临原料药规模化生产的限制。

我们预测Foundayo在2026年/2035年的销售额分别为14亿美元/290亿美元，而Visible Alpha共识预期为13亿美元/270亿美元。

## 诺和诺德关于口服Wegovy海外上市的最新评论

2026年6月3日（诺和诺德新闻稿）：宣布在阿拉伯联合酋长国推出Wegovy口服片，标志着该肥胖症适应症在美国以外的首次上市。

- 根据公告，诺和诺德重申计划在2026年下半年在另外几个选定市场推出Wegovy口服片。

2026年5月22日（诺和诺德新闻稿）：Wegovy口服片（口服司美格鲁肽）获得欧洲药品管理局人用药品委员会推荐在欧盟批准，成为首个口服GLP-1，代表其类别中最有效的口服肥胖症治疗方法。

- “对有效且便捷的肥胖症治疗的需求在美国已经显而易见，超过100万美国人在上市后的前四个月内开始使用Wegovy®口服片。我们期待在2026年下半年将这种创新药物带到美国以外的首批市场。”

1Q26 每股收益：“……关于口服Wegovy

的供应。您提到了在几个国际运营市场的上市。您认为能维持多少个市场？总体而言，供应情况如何？”

- “关于供应，我想说的是，虽然由于产品设计，我们无法无限量供应Wegovy药片，但尽管我们在美国市场凭借Wegovy片剂创下了产品采用率的新纪录，我们今年仍能宣布在美国以外的首批市场上市。这充分说明了我们在供应规模扩大库存建立方面取得的进展。然后，我们将在此基础上逐步推进国际推广的步伐。”

- Wegovy药片预计将于2026年下半年在部分市场上市。

年度股东大会：“我们迄今看到的以及持续出现的惊人采用率对我们有利。因为当竞争来临时，我们将拥有数万甚至数十万用户。这将证明他们有多么满意。当然，这也会帮助我们让这款药片取得成功。现在，我们不会轻视竞争。我们会做好准备，确保一切就绪。但我认为产品本身正在帮助我们。与此同时，我们目前也在关注美国以外的市场，试图找出下一步应该在何处以及如何上市。敬请期待。一旦我们公开，你们就会听到消息。”

4Q25 每股收益：“鉴于Wegovy药片的强劲上市，2026年是否存在供应中断的风险？例如，如果采用率保持在当前高位，诺和诺德能否凭借现有产能满足今年剩余时间的需求？”

- “在过去一段时间里，我曾多次谈到我们对Wegovy药片供应充满信心。我们基本上说过，我们在美国推出这款药片时，已经足够确信我们不会再陷入供应紧张的局面。可以说，我们在第一个月看到了令人难以置信的采用率。今天，我要再次向你们确认，我们对于能够供应美国市场感到极其自信。”

## 仿制GLP-1值得关注，利好药品包装公司

我们认为，GLP-1 仿制药的推出对 WST 和 STVN 等药品包装公司而言是增量增长机遇。WST 和 STVN 在 GLP-1 注射剂领域均有强大布局。值得注意的是：

- GLP-1 约占 WST 公司总收入的 18%，其中约 10% 来自弹性体组件，约 8% 来自 West Vantage（合同制造）。

WST 的产品组合涵盖多种剂型，包括使用 WST 弹性体组件的西林瓶、预充式注射器、自动注射器和注射笔。WST 约 90% 的 GLP-1 业务来自品牌产品，10% 来自仿制药。

- GLP-1 约占 STVN 公司总收入的 19-20%。STVN 服务于 GLP 市场的关键产品包括公司的 Nexa 注射器和用于多剂量注射笔的 EZ-fill 卡式瓶。

预计 GLP-1 仿制药带来的降级消费微乎其微。WST 和 STVN 主要通过其高价值产品组合中的产品服务于 GLP-1 市场。与其标准产品组合中的产品相比，高价值产品具有更高的平均售价和更好的利润率。根据我们与管理层的沟通，WST 和 STVN 均预计从品牌 GLP-1 向仿制药的降级消费极少。我们认为，仿制药制造商将在其药物主文件中采用品牌原研药所使用的类似高价值初级包装规格，以降低监管风险，这使得 WST 和 STVN 能够继续从其高价值产品组合中供应利润最高的产品，并实现可观的收入增长传导至每股收益。

GLP-1 仿制药可能因数量折扣减少而带来平均售价的顺风。WST 和 STVN 的商业模式中，通常向大客户提供数量折扣。我们认为，这一动态可能部分解释了为何 WST 和 STVN 2026 年指引中隐含的 GLP-1 增长假设显著低于市场对当前市场上 GLP-1 注射剂的普遍预期。虽然品牌 GLP-1 市场目前是双头垄断，但我们预计仿制 GLP-1 市场将更加分散，参与者将无法获得同等水平的数量折扣。

我们试图量化 GLP-1 仿制药对 WST 和 STVN 中期增长的影响。我们的情景分析假设 GLP-1 仿制药将在很大程度上增加 GLP-1 的销量增长，并有助于扩大 GLP-1 患者群体。我们的方法如下：

- 我们假设 WST 和 STVN 的 GLP-1 收入增长将与 GLP-1 注射剂的患者数量增长挂钩（而非市场上 GLP-1 注射剂的制药收入增长），我们借鉴了MS医药团队 GLP-1 市场模型的数据。
- 对于 WST 和 STVN，我们建立了一个基准情景，假设仿制 GLP-1 带来的 GLP 患者群体扩张为 0%，作为基线参考。
- 我们假设两种情景，即仿制 GLP-1 将 GLP 患者群体规模分别扩大 10% 和 20%。
- 为了隔离 GLP-1 仿制药对公司增长的影响，我们在上述三种情景下均假设 WST 和 STVN 的非 GLP-1 业务保持恒定增长率。

图表 43：WST GLP-1 仿制药情景分析

来源：MS估计

图表 44：STVN GLP-1 仿制药情景分析

来源：MS估计

我们的分析发现，假设仿制药能将 GLP-1 患者群体扩大 10-20%，则可为 WST 带来 30-50 个基点的增量增长。对 STVN 采用相同的 GLP-1 患者群体扩张假设，我们发现仿制 GLP-1 可带来 70-120 个基点的增量增长。这一差异主要归因于 STVN 公司层面的 GLP-1 业务占比（19-20%）高于 WST 的弹性体业务占比。

## 关键股票结论

### 原研药企

**诺和诺德（低配）：**我们预计诺和诺德在专利到期后将面临压力

礼来（超配）：我们预计礼来的产品组合能更好地抵御仿制药压力，原因在于：(1) Mounjaro（GLP-GIP）与司美格鲁肽（GLP）在肥胖和2型糖尿病头对头3期临床数据上的差异化，(2) 拥有多种新作用机制的管线药物组合，如 Retatrutide（GLP-GIP-胰高血糖素）和 Eloralintide（选择性胰淀素），以及 (3) 可扩展的口服 GLP-1 药片 Foundayo。我们预测礼来肠促胰岛素产品组合的销售额将从2026年的600亿美元增长至2035年的1010亿美元。

## 仿制药企、CDMO及供应商

瑞迪博士实验室（低配）：瑞迪博士是加拿大、印度等市场仿制司美格鲁肽的早期进入者，拥有自产原料药以及合作伙伴主导的注射笔制造/灌装和封装能力。该公司正在迅速扩大产能（目标是在2028财年生产超过4000万支注射笔，而2026年为600-700万支），并积极拓展全球市场，包括加拿大等成熟的GLP-1市场。该公司正将自己定位为一家规模化、全球化的仿制药企，利用成本领先优势、一体化制造和供应链控制来获取市场份额。

Divi's Labs (OW)：该公司旨在成为全球最大的多肽生产商之一，目前拥有印度最大的固相多肽合成（SPPS）规模（即多个约3,000升的反应釜）。管理层确认，公司参与了多家跨国药企GLP-1项目（包括创新药）原料药的氨基酸和片段生产。因此，我们认为Divi's Labs通过涉足原料药生产，有望成为GLP-1市场容量扩张的潜在受益者。

Sandoz (UW)：Sandoz预计将于2026年下半年在加拿大Daiwa巴西推出司美格鲁肽仿制药，并计划在2030年代初欧美专利到期之前，于2027年进军墨西哥等其他市场。公司正在为首批市场合作开发原料药及灌装与包装，并将根据首批专利到期市场的动态，决定是否投资原料药及灌装与包装产能。我们目前的模型基于加拿大Daiwa巴西的机会，仅计入GLP-1在2027年的有限贡献；如果Sandoz在加拿大Daiwa巴西成为市场份额领导者，且价格稳定在可接受水平，那么GLP-1仿制药可能为我们的预测带来上行空间，尤其是如果Sandoz决定投资灌装与包装制造以进军美国和欧洲市场。我们目前预计，到2030年，Sandoz的Ozempic仿制药在加拿大的销售额约为1-1.2亿美元（意味着在加拿大Ozempic仿制药市场中占据15-20%的份额）。

Medtide (3880.HK, EW)：作为美国FDA进口绿名单上为数不多的中国司美格鲁肽原料药供应商之一，Medtide拥有吨级产能。然而，它是一家专注于多肽和寡核苷酸的CDMO，服务于创新药合同。迄今为止，与专注于司美格鲁肽原料药供应的Hybio Pharma (300199.SZ, 未覆盖) 和Jiangsu Sinopep (688076.SH, 未覆盖) 不同，它尚未宣布进军司美格鲁肽生物类似药市场的计划。

United Labs (3933.HK, EW)：中国最早提交司美格鲁肽生物类似药申请的公司之一。作为中国成熟的胰岛素企业，它拥有销售网络来推广其糖尿病-肥胖症产品线中的其他产品。诺和诺德于2025年获得了United Labs三重激动剂UBT251（GLP-1/GIP/胰高血糖素）的中国以外权利（试验进行中）。

Hypera (OW)：Hypera在巴西通过推出司美格鲁肽仿制药获得的机会取决于执行情况，但潜力巨大：如果公司及时获得Anvisa批准，并在品牌司美格鲁肽仿制药的早期阶段推出，它可以直接参与一个市场的扩张和正规化，该市场需求已经存在，但部分需求仍因价格过高而被排除在合法渠道之外。EMS的先发优势和本地制造能力是相关的竞争障碍，但随着司美格鲁肽从高端利基市场转向更广泛的大众市场疗法，市场应演变为多参与者的

品牌仿制药领域，HYPE的医生关系、营销能力、零售覆盖范围和品牌建设能力可支持其获得市场份额。

Raia Drogasil (OW)：我们认为，随着司美格鲁肽价格下降，GLP-1的可及性将超越狭窄的高收入利基市场，同时目前由未经授权的进口和复合替代品满足的需求将转向正规药房渠道，这推动了巴西可寻址市场的扩张。虽然较低的价格可能对平均客单价造成压力，但弹性应能支撑更高的销量、客流量和重复处方需求，而RADL凭借其全国性网络、数字化能力、供应商关系以及销售品牌和仿制GLP-1的能力，能够很好地抓住这一转变。

## 药品包装

West Pharmaceutical Services (EW)：我们认为，GLP-1仿制药将成为WST的增量增长驱动力，并估计到2030年，它可能推动每年30-50个基点的增长。我们预计从品牌GLP-1到仿制GLP-1的产品降级微乎其微，这使得WST能够以其高价值产品组合服务于GLP-1仿制药市场，这应能推动显著的收入增长传导至每股收益。此外，我们认为，由于仿制药生产商无法获得与两大品牌GLP-1生产商相同水平的量价折扣，因此平均售价存在上行潜力。

Stevanato Group (EW)：我们认为，基于与WST相同的上述原因，STVN将从GLP-1仿制药中受益。然而，由于公司19-20%的业务涉及GLP-1，我们预计STVN的受益程度将更大。

股价：Novo Nordisk 284.90 丹麦克朗，Eli Lilly 1,082.20 美元，Dr Reddy's 1,274.00 印度卢比，Divi's Labs 6,533.00 印度卢比，Sandoz 64.22 瑞士法郎，Medtide 19.63 港元，United Labs 9.07 港元，Hypera 21.43 巴西雷亚尔，Raia Drogasil 17.86 巴西雷亚尔，Hims & Hers 27.51 美元，WST 317.32 美元，STVN 18.51 美元。